2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

A RUA TAMBÉM FALA: REFLEXÕES DA ENFERMAGEM NO CUIDADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Helena Gonçalves de Souza Santos (SANTOS, H. G. S.)[1] - Doutoranda em Enfermagem (EEAN-UFRJ).
Márcia de Assunção Ferreira (FERREIRA, M. A.)[2] - Departamento de Enfermagem Fundamental. Escola de Enfermagem Anna Nery.
Eduardo de Lima Fonseca (FONSECA, E. L.)[3] - Mestrando em Relações Étnico-Raciais(PPRER-CEFET).
Ricardo Mattos Russo Rafael(RAFAEL, R. M. R)[4] - Departamento de Enfermagem de Saúde Pública (FAENF - UERJ).
Davi Gomes Depret (DEPRET, D. G.)[5] - Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. (UNIRIO)

PRINCIPAIS ACHADOS DO SEU TRABALHO

O cuidado à população em situação de rua exige práticas flexíveis, territorializadas e sensíveis às singularidades do viver na rua, rompendo com modelos rígidos de acesso e acompanhamento. Estratégias como agendas adaptadas, construção de vínculo longitudinal, escuta qualificada e articulação interprofissional/intersetorial mostraram-se fundamentais para ampliar continuidade do cuidado, autonomia dos usuários e efetivação da cidadania sanitária.

Introdução
As pessoas em situação de rua não são apenas deslocadas do espaço urbano, são, sobretudo, produzidas por um sistema que naturaliza a exclusão, a invisibilidade e a necropolítica do descarte. Vivenciam vulnerabilidades complexas e entrelaçadas: ausência de documentos, transtornos mentais severos, dependência química estigmatizada, violência institucional, fome, frio e uma constante interrupção de qualquer continuidade assistencial. O estigma opera como barreira intransponível quando o cuidado se limita ao espaço fechado da unidade de saúde. É nesse cenário que a Enfermagem de Família e Comunidade (EFC) assume posição radicalmente política: reconhecer a rua como território de saúde legítimo, pulsante, que também fala, que também sofre e que também exige resposta. O cuidado sensível, flexível e territorializado rompe com o paradigma tradicional de acesso (centrado na unidade) e propõe um encontro ético onde o profissional vai até o outro, sem julgamento, sem condicionalidades. Este relato não descreve uma experiência heroica ou assistencialista. Ao contrário: expõe desafios reais, contradições do cotidiano e a potência de uma práxis que insiste em fazer do vínculo um ato de resistência sanitária.

Objetivos
Relatar desafios e estratégias vivenciados no cuidado à população em situação de rua em uma clínica da família do Rio de Janeiro.

Métodos
Relato de experiência baseado na prática profissional, observações cotidianas, interações com usuários e participação em ações intersetoriais.

Resultados
Evidenciaram-se dificuldades relacionadas ao acesso, à comunicação, à complexidade social e ao acolhimento de demandas urgentes. Estratégias como agendas adaptadas, construção de vínculo, trabalho em equipe e articulação com a rede ampliaram a continuidade do cuidado.

Conclusão/Considerações finais
A rua, enquanto espaço vivo e não como vazio sanitário, impõe à Enfermagem uma desconstrução profunda de suas próprias práticas. Não se trata de adaptar agendas ou estender horários como meros ajustes técnicos. Trata-se de reconhecer que o cuidado, quando não é produzido no território onde a vida acontece, ainda que essa vida esteja sob marquises, barracas ou viadutos, torna-se mais uma violência simbólica. A atuação da EFC demonstrou, neste relato, ser não apenas necessária, mas intransferível para ampliar a cidadania sanitária. Ao construir vínculos duradouros, articular a rede intersetorial (assistência social, justiça, habitação) e sustentar uma escuta que não patologiza a pobreza, a enfermagem produz autonomia onde antes só havia repetição da exclusão. A rua fala. A enfermagem, quando decide ouvir, descobre que seu lugar é estar onde o sistema insiste em não chegar. Conclui-se que práticas sensíveis, flexíveis e situadas não são opções estéticas do cuidado, são exigências éticas para que nenhum corpo em situação de rua continue sendo tratado como sobra.

ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY - UFRJ
HELENA GONÇALVES DE SOUZA SANTOS
DOUTORANDA

E-mail: enfa.helenagss@gmail.com
Contatos: +55 (21)997853101

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Enfermagem